TEMA 2 · Organización de los cuidados en AP y AE. Ley General de Sanidad y Ley de Salud de la Región de Murcia

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Organización de los cuidados enfermeros y nuevos roles · Bloque B: Ley 14/1986, Ley 4/1994, mapa sanitario y estructura del SMS

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
AP / AE	Atención Primaria / Atención Especializada	Los dos niveles asistenciales
SNS	Sistema Nacional de Salud	Conjunto de los Servicios de Salud del Estado y de las CC. AA.
CC. AA.	Comunidades Autónomas	
SMS	Servicio Murciano de Salud	Servicio de Salud de Murcia: gestiona centros y personal
CISNS	Consejo Interterritorial del SNS	Coordina el Ministerio y las CC. AA.
ZBS / EAP	Zona Básica de Salud / Equipo de Atención Primaria	Territorio del centro de salud / su equipo
EPA	Enfermería (o enfermera) de Práctica Avanzada	Rol clínico ampliado con posgrado
EGC	Enfermera Gestora de Casos	Crónicos complejos
EIR	Enfermero/a Interno/a Residente	Vía de formación de las especialidades
CIE	Consejo Internacional de Enfermeras	Organización mundial de la enfermería
EpS	Educación para la Salud	
NANDA / NOC / NIC	Diagnósticos / Resultados / Intervenciones de enfermería	Lenguajes enfermeros estandarizados
HCE	Historia Clínica Electrónica	En el SMS: OMI-AP (primaria) y Selene (hospital)
LGS (Ley 14/1986)	Ley General de Sanidad	Crea el SNS, las Áreas de Salud y las ZBS
Ley 41/2002	Ley de Autonomía del Paciente	Consentimiento, historia clínica, instrucciones previas
Ley 16/2003	Ley de Cohesión y Calidad del SNS	Cartera de servicios
LOPS (Ley 44/2003)	Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias	Títulos y funciones
Ley 55/2003	Estatuto Marco del personal estatutario	Trabajo: jornada, permisos, carrera
Ley 33/2011	Ley General de Salud Pública	
RD 450/2005	Real Decreto de especialidades de Enfermería	Especialidades vía EIR
RD 954/2015 (modificado por el RD 1302/2018)	Real Decreto de indicación enfermera	«Prescripción» enfermera
Ley 4/1994	Ley de Salud de la Región de Murcia	Crea el SMS y el mapa sanitario
Ley 3/2009	Ley de derechos y deberes de los usuarios (Murcia)	Ver tema 3
Decreto 54/2016	Órganos de participación del sistema sanitario de Murcia	Consejos de Salud

A1. Los dos niveles asistenciales y los atributos de la Atención Primaria (AP)

Nivel	Qué es	Acceso
Atención Primaria (AP)	Nivel básico, **puerta de entrada**; gestiona, coordina casos y regula flujos	Directo
Atención Especializada (AE)	Mayor complejidad diagnóstica y terapéutica (ambulatoria u hospitalaria)	Por **derivación** desde AP

Los 4 atributos de la AP (Barbara Starfield)

- **Accesibilidad (primer contacto)**: no solo geográfica; también económica, cultural y organizativa (en Murcia, gestor de citas único).
- **Longitudinalidad**: relación personal y continuada en el tiempo entre paciente y profesional, **esté o no enfermo**. Es lo contrario de la atención episódica.
- **Integralidad**: abordaje **biopsicosocial** de la persona en su contexto.
- **Coordinación**: la AP guía al paciente por el resto del sistema y evita la fragmentación.

Contexto en Murcia y evolución del modelo

- **EMAP 2023-2026** (Estrategia de Mejora de la Atención Primaria del SMS): pasar de un modelo **reactivo** a uno **proactivo, comunitario y salutogénico**; reduce ratios enfermera/población y potencia la salud comunitaria.
- La enfermería evoluciona hacia: autonomía (consultas propias), especialización (vía EIR), nuevos roles (gestora de casos, enlace, escolar, práctica avanzada), orientación comunitaria y gestión de la cronicidad, e integración tecnológica (historia clínica electrónica, telemedicina, estratificación).

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Longitudinalidad ≠ continuidad**. Longitudinalidad = relación en el tiempo con el profesional. Continuidad = que el proceso asistencial no se corte (que la información fluya del hospital al centro de salud).

! Si te definen el abordaje biopsicosocial, el atributo es la **Integralidad**.

! Las fechas de la EMAP son **2023-2026**; en el examen cambian los años para confundir.

A2. Marco normativo básico

Norma	Fecha	Palabra clave para el test
Constitución Española, art. 43	27/12/1978	Derecho a la protección de la salud
Ley 14/1986 General de Sanidad (LGS)	25/04/1986	Crea el **SNS**; Áreas de Salud y ZBS
Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente	14/11/2002	Consentimiento informado, historia clínica, instrucciones previas
Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS	28/05/2003	**Servicios**: cartera de servicios
Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)	21/11/2003	**Títulos y funciones**: competencias, formación especializada
Ley 55/2003 (Estatuto Marco)	16/12/2003	**Trabajo**: derechos, deberes, jornada, permisos
Ley 33/2011 General de Salud Pública	04/10/2011	Vigilancia epidemiológica, prevención
Real Decreto (RD) 450/2005 de especialidades de Enfermería	22/04/2005	Especialidades vía EIR (Enfermero Interno Residente, 2 años de residencia)
Ley 4/1994 de Salud de la Región de Murcia	26/07/1994	Adaptación murciana de la LGS: 9 Áreas de Salud
Ley 3/2009 de derechos y deberes (Murcia)	11/05/2009	Adaptación murciana de la Ley 41/2002
Decreto 12/2018 (Estatutos del Servicio Murciano de Salud, SMS)	07/03/2018	Estructura: gerencias, direcciones de enfermería

CLAVE PARA RECORDAR

- Truco del "trío de 2003": **Ley 16/2003 (Cohesión) = servicios**, **Ley 44/2003 (LOPS) = títulos y funciones**, **Ley 55/2003 (Estatuto Marco) = trabajo**.
- Especialidades en la práctica (6): Familiar y Comunitaria, Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Salud Mental, Pediátrica, Geriátrica y del Trabajo. El RD 450/2005 recoge también Cuidados Médico-Quirúrgicos, pero no se ha desarrollado ni se oferta por EIR.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Vacaciones, permisos o carrera profesional: **Estatuto Marco (Ley 55/2003)**, no la LOPS.

! Las 9 Áreas de Salud de Murcia: **Ley 4/1994**. El concepto general de Área de Salud para toda España: **Ley 14/1986**.

A3. Organización de los cuidados en Atención Primaria

Organización territorial

Estructura	Claves
Área de Salud	Gestión unitaria de AP y AE. Orientativamente **200.000-250.000 hab.** Murcia tiene **9**
Zona Básica de Salud (ZBS)	Unidad territorial básica de la AP: el territorio del **Equipo de Atención Primaria (EAP)**. **5.000-25.000 hab.** (modificable por dispersión)
Centro de Salud	Sede física y funcional del EAP
Consultorio Local	Depende funcionalmente del Centro de Salud; zonas rurales o dispersas

- **EAP**: médicos de familia, pediatras, enfermeras, matronas, trabajadores sociales, fisioterapeutas y administrativos. Trabajo interdisciplinar, historia clínica común y responsabilidad compartida. Su núcleo es la **Unidad Básica Asistencial (UBA)**: un **médico y una enfermera** que comparten la misma población.
- Ratio recomendado: **1 enfermera por cada 1.500-2.000 tarjetas sanitarias**.

Modalidad	Qué hace
Enfermera de cupo	Población asignada propia (o compartida con el médico de familia)
Enfermera de equipo	Actividades transversales para todo el EAP (Educación para la Salud o EpS, programas comunitarios)
Enfermera de enlace	Continuidad entre AP y AE
Enfermera gestora de casos	Crónicos complejos y pluripatológicos

Modelos de atención

- **Tradicional (reactivo)**: demanda espontánea y procesos agudos.
- **Proactivo / gestión de la cronicidad**: población asignada, estratificación por riesgo, seguimiento protocolizado.
- **Chronic Care Model (CCM, modelo de atención a crónicos)**: interacción entre un **paciente informado y activo** y un **equipo proactivo**, con sistemas de información y recursos comunitarios.

Funciones de la enfermera de AP

- **Asistencial**: consulta programada, a demanda y telefónica; atención domiciliaria (orienta, aconseja, educa y aplica cuidados; ver tema 11); técnicas (curas, extracciones, ECG, espirometrías, vacunas); programas (niño sano, mujer, crónicos, anciano).
- **Promoción y prevención**: EpS en 3 áreas de igual importancia: **consulta** (individual), **grupos** y **comunidad**.
  - Prevención **primaria**: vacunas, consejo antitabaco, dieta y ejercicio (la enfermedad no existe).
  - Prevención **secundaria**: cribados (mama, colon, cérvix), hipertensión (HTA) silente, violencia de género.
  - Prevención **terciaria**: evitar complicaciones de lo que ya existe (úlceras por presión o UPP, caídas).
- **Gestión y coordinación**: gestión de casos, informes de derivación/alta, agenda, comisiones.
- **Docente e investigadora**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **200.000-250.000 hab. = Área de Salud (9 en Murcia). 5.000-25.000 hab. = ZBS (90 en Murcia).**

! La enfermera que organiza EpS afectivo-sexual en institutos para toda la población es **de equipo**; la que atiende a sus 1.500 tarjetas es **de cupo**.

! Vacuna = primaria; sangre oculta en heces o citología = secundaria; prevenir UPP en inmovilizado = terciaria.

! "Paciente activo + equipo proactivo" = **Chronic Care Model**.

A4. Organización de los cuidados en Atención Especializada

- **Hospital**: internamiento, ambulatorio y urgencias. Por complejidad: alta resolución, generales y **de referencia** (en Murcia: **Virgen de la Arrixaca** y **Santa Lucía**).
- **Servicio clínico**: lo dirige el **Jefe de Servicio** (médico); los cuidados los organiza el **Supervisor de Enfermería**.
- **Unidad de enfermería (planta)**: asignación de pacientes por turno, enfermera responsable y TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería).
- **Unidades especiales** (menor ratio enfermera/paciente): UCI (Cuidados Intensivos), REA (Reanimación), Coronaria, Ictus, Neonatología.
- **Dirección de Enfermería**: Director/a → Subdirectores/as → Supervisores/as generales → Supervisores/as de unidad.
- Otros servicios: urgencias (triaje), bloque quirúrgico (circulante, instrumentista, enfermera de URPA, la Unidad de Recuperación Postanestésica), consultas externas, hospital de día.
- **Consultas de enfermería de Atención Especializada (AE)**: diabetes, insuficiencia cardiaca, ostomías, heridas complejas, anticoagulación (control del INR).

La enfermera de enlace hospitalaria

Garantiza la **transición segura del hospital al domicilio** u otros recursos. Detecta pacientes complejos, planifica el alta, elabora el **informe de continuidad de cuidados**, coordina con AP y servicios sociales, educa al cuidador y hace seguimiento telefónico tras el alta. Reduce reingresos evitables y es coste-efectiva.

	Atención Primaria	Atención Especializada
Enfoque	Promoción, prevención, curación, rehabilitación	Diagnóstico complejo, tratamiento intensivo/quirúrgico
Lugar	Centro de salud, domicilio, comunidad	Hospital, centros de especialidades
Problemas	Alta frecuencia, baja complejidad tecnológica	Baja frecuencia, alta complejidad tecnológica
Unidad funcional	EAP	Servicio clínico
Acceso	Directo	Por derivación
Población	Toda, asignada por ZBS y cupo	Seleccionada por patología
Contenido	Generalista, integral, biopsicosocial	Especializado, biomédico
Temporalidad	**Longitudinal**	**Episódica**

TRAMPAS DE EXAMEN

! Quien organiza los cuidados de un servicio hospitalario es el **Supervisor de Enfermería**, no el Jefe de Servicio.

! **URPA**: despertar tras la anestesia (horas). **REA**: postoperatorio inmediato de cirugía mayor, casi una unidad de críticos (días).

! AP = longitudinal; AE = episódica.

A5. Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) e indicación enfermera

- **Definición del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE, 2020)**: enfermera titulada con conocimientos de experto, capacidad de decisiones complejas y competencias clínicas para un ejercicio profesional **ampliado**. Requiere posgrado (máster/doctorado).

- Consolidada en EE. UU., Canadá, Reino Unido y Australia (*Nurse Practitioner*): diagnóstico diferencial, prescripción, petición de pruebas.
- Modelos: **sustitución** (asume funciones médicas), **complementariedad** (sin sustituir al médico) e híbridos.
- 5 dimensiones de rol: asistencial, liderazgo, educación, investigación y consultoría.
- **En España NO está regulada** como figura diferenciada (tampoco en el SMS). Hay pilotos en cronicidad, IC, EPOC, paliativos y heridas. Barreras: falta de marco legal, indefinición competencial, resistencias y falta de reconocimiento.

	Especialista (EIR)	EPA
Formación	EIR, 2 años de residencia	Posgrado (máster o doctorado)
Estatus	Regulada (RD 450/2005)	No regulada en el SNS ni en el SMS
Competencias	Diagnóstico enfermero (NANDA-I) en su área	Diagnóstico diferencial y petición de pruebas
Prescripción	No ampliada: indicación general enfermera	Ampliada y autónoma en su área

"Prescripción enfermera": RD 954/2015 modificado por el RD 1302/2018

- Término legal: **indicación, uso y autorización de dispensación** de medicamentos y productos sanitarios.
- Objeto del RD: las actuaciones de indicación enfermera, la elaboración y validación de los protocolos y guías, y el **procedimiento de acreditación** de las enfermeras. Se aplica en la sanidad **pública y privada**.
- Requiere **acreditación de la Comunidad Autónoma** (no del Ministerio ni del Colegio), tanto la enfermera de cuidados generales como la especialista. Requisitos (ámbito general): título de Grado, Diplomado o ATS **y**, además, **1 año de experiencia** o un curso de adaptación gratuito de la Administración (ninguno de ellos basta por sí solo).
- **Autónoma**: productos sanitarios (apósitos, sondas, tiras, bolsas de ostomía, pañales) y medicamentos **no sujetos** a prescripción médica.
- **Colaborativa / protocolizada**: medicamentos **sujetos** a prescripción (vacunas, insulinas, pomadas antibióticas, anestésicos locales) solo con **protocolos o guías validados por el Ministerio**. Guías aprobadas: heridas, quemaduras, ostomías, anticoagulación oral, hipertensión (HTA), diabetes tipo 1 y 2, infección urinaria (ITU) no complicada en mujeres.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El término legal es la opción larga: **"indicación, uso y autorización de dispensación"**, no "prescripción autónoma".

! Ser especialista EIR **no** convierte en EPA ni permite pedir radiografías o recetar antibióticos por cuenta propia.

! Apósitos de plata (producto sanitario): indicación **autónoma**. Los protocolos son obligatorios solo para medicamentos sujetos a receta.

A6. La consulta de enfermería

- Espacio físico y temporal donde la enfermera, **de forma autónoma**, aplica el **Proceso de Atención de Enfermería (PAE)** (valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación) con NANDA-I, NOC y NIC.
- Características: autonomía, accesibilidad, continuidad, integralidad y atención centrada en la persona.
- Tipos: por nivel (AP generalista y longitudinal; AE por derivación y orientada a patologías), por modalidad (presencial, telefónica, teleconsulta) y por finalidad (valoración inicial, seguimiento, educación terapéutica, técnicas).

Tipo de consulta	Duración orientativa
A demanda	10-15 min
Programada (objetivo: control y seguimiento de los problemas o necesidades ya conocidos)	15-20 min
Primera valoración integral	30-40 min

Valoración	Escalas
Funcional (actividades básicas de la vida diaria, ABVD)	Barthel, Katz
Funcional (actividades instrumentales, AIVD)	Lawton

Valoración	Escalas
Cognitiva	Pfeiffer, MEC (Mini Examen Cognoscitivo de Lobo)
Riesgo de úlceras por presión (UPP)	Braden, Norton
Nutrición	MNA (Mini Nutritional Assessment)

TRAMPAS DE EXAMEN

! **NANDA = diagnóstico; NOC = resultados (objetivos); NIC = intervenciones.** (Las tres se explican en el tema 3.)

! Además de la continuidad asistencial, el registro sirve como **protección legal**: "lo que no está registrado no está hecho".

A7. Coordinación entre niveles asistenciales

- **Continuidad asistencial**: grado en que los servicios se coordinan entre profesionales, organizaciones y niveles a lo largo del tiempo, de modo que el paciente percibe una atención sin rupturas.
- **3 dimensiones**: de **información** (los datos llegan), de **gestión** (los servicios no se solapan ni contradicen) y de **relación** (vínculo estable con los profesionales de referencia).
- Mecanismos: historia clínica electrónica (HCE) compartida (**OMI-AP** en AP y **Selene** en AE), informes de derivación y de alta, **informe de continuidad de cuidados** de enfermería, protocolos de derivación (criterios, circuitos, información mínima, tiempos y criterios de retorno), vías clínicas compartidas y figuras de enlace y gestora de casos.
- **Vías clínicas**: multidisciplinares, multinivel, estandarizadas y orientadas a resultados. Su objetivo clave es **reducir la variabilidad clínica**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Programa de AP del SMS: **OMI-AP**. Programa hospitalario: **Selene**.

! "El médico de AP ve la analítica del hospital" = continuidad de **información**. "Mismo protocolo para no duplicar pruebas" = continuidad de **gestión**.

A8. Enfermera referente, escolar y gestora de casos

Enfermera referente (Primary Nursing)

- Modelo de **Marie Manthey** (EE. UU., años 70). Una enfermera es responsable del plan de cuidados de sus pacientes **24 h, del ingreso al alta**, aunque otras (asociadas) lo ejecuten en otros turnos.
- Principios: responsabilidad individual, continuidad y comunicación directa.

Modelo	Organización
Funcional (por tareas)	Cada una hace una tarea (medicación, curas, constantes): muy fragmentado
En equipo	Responsabilidad compartida por un grupo liderado por una enfermera
Primaria / referente	Responsabilidad personalizada de un grupo de pacientes

- En el SMS predominan los modelos **por turnos y en equipo**, con evolución hacia la individualización. No está implantado en su totalidad.

Enfermera escolar

- Trabaja en centros educativos. Origen a finales del s. XIX (EE. UU. y Reino Unido).
- Funciones: promoción y prevención, atención a crónicos (diabetes, asma, epilepsia, alergias), urgencias y primeros auxilios (coordinación con el 112), vigilancia epidemiológica, detección precoz y formación.
- Documento clave: **Plan de Atención Individualizado (PAI)**.
- **No hay norma estatal que obligue** a su presencia. En Murcia está sobre todo en **Centros de Educación Especial**. En los colegios ordinarios, la EpS la hace la **enfermera de AP** de la ZBS.

Enfermera gestora de casos (EGC)

- Coordina la asistencia y defiende los intereses del paciente para conseguir mejores resultados y calidad con menos costes y recursos. Gestión integral, **longitudinal y proactiva** de pacientes de alta complejidad: crónicos complejos, **pluripatológicos** (criterios de **Ollero**: 8 categorías, de la A a la H; pluripatológico si cumple 2 o más), frágiles e hiperfrecuentadores.
- Perfil: grado, preferiblemente especialista en Familiar y Comunitaria o experiencia en AP, y formación en cronicidad.
- Marcos teóricos: Chronic Care Model, **Kaiser Permanente** (pirámide de estratificación del riesgo, **3 niveles**) y CMSA (Case Management Society of America).

Nivel Kaiser	Población	Intervención
1	Sanos o riesgo bajo (70-80%)	Promoción y prevención
2	Riesgo medio, crónicos estables (15%)	Gestión de la enfermedad (seguimiento protocolizado)
3	Alta complejidad (5%)	**Gestión de casos**

- Ojo: el manual (pág. 32) pone en el nivel 1 a la «población sana o de riesgo bajo», pero una pregunta del EIR da como cierto que en el nivel 1 están los **crónicos con buen control** de su enfermedad (apoyo al autocuidado). Si sale, esa es la respuesta del EIR.
- Reconocida en la **Estrategia de Cronicidad del SNS (2012)**. Comunidad pionera: **Andalucía**. En Murcia se ubica sobre todo en AP, con implantación intermedia.

Repercusión de los nuevos roles

- Paciente: mejor control (hemoglobina glicosilada o HbA1c, tensión arterial, exacerbaciones de EPOC e insuficiencia cardiaca o IC), menos UPP, caídas e infecciones, más calidad de vida y satisfacción.
- Sistema: **ingresos −10-30%**, **reingresos a 30 días −15-40%**, **urgencias −15-35%**, menos estancias. Retorno de **1,5 a 3 € por cada euro** invertido. Patologías diana: IC, EPOC y diabetes.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Autora de la enfermería primaria/referente: **Marie Manthey** (no Henderson ni Orem).
>
> ! Referente = cuida al paciente **durante el ingreso**. Enlace = **transición al alta**. Gestora de casos = crónico complejo **a largo plazo**.
>
> ! La EGC actúa en el **nivel 3** de Kaiser. Pluripatológico = **criterios de Ollero**. Pionera: **Andalucía**.
>
> ! La EGC es **coste-efectiva**; el indicador que mejor refleja el éxito del enlace es la **tasa de reingresos a 30 días**.

BLOQUE B · Ley 14/1986 General de Sanidad, Ley 4/1994 y estructura del SMS

B1. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad

- Desarrolla el **art. 43 de la Constitución (CE)** (derecho a la protección de la salud). Es la piedra angular del ordenamiento sanitario: **crea el Sistema Nacional de Salud (SNS)**.
- **Titulares del derecho (art. 1.2)**: todos los **españoles** y los **extranjeros que tengan establecida su residencia** en España.
- Fechas: aprobada el **25/04/1986**, publicada en el BOE el **29/04/1986**, en vigor el **19/05/1986** (a los 20 días).
- Principios: **integralidad** (promoción, prevención, curación y rehabilitación) y **universalidad** (toda la población en igualdad efectiva).
- **Art. 44**: todas las estructuras públicas se integran en el **SNS**, conjunto de los Servicios de Salud del Estado y de las Comunidades Autónomas (CC. AA.).

Características del SNS (art. 46)

1. Extensión a **toda la población**.
2. Atención **integral** de la salud (promoción, prevención, curación, rehabilitación).
3. **Coordinación e integración** de todos los recursos públicos en un dispositivo único.
4. **Financiación pública** (fundamentalmente impuestos; también cotizaciones y tasas).
5. Prestación de una atención de **calidad**, evaluada y controlada.

Consejo Interterritorial del SNS (CISNS)

- Órgano permanente de **coordinación, cooperación, comunicación e información** entre los servicios de salud y el Estado. No presta asistencia; su papel es político y planificador (p. ej., informa la cartera común de servicios, que se aprueba por **Real Decreto**).
- **Preside** el titular del **Ministerio de Sanidad**. Vicepresidencia: un consejero autonómico elegido entre ellos. Vocales: los consejeros de sanidad de todas las CC. AA. y de Ceuta y Melilla.

Servicios de Salud de las CC. AA. y Áreas de Salud

- En cada CA se crea un **Servicio de Salud** (arts. 41 y 50) que integra todos los centros públicos de su territorio (propios, diputaciones y ayuntamientos).
- El **Estado** conserva sanidad exterior, **relaciones y acuerdos sanitarios internacionales**, homologación de títulos, legislación farmacéutica y coordinación general; las CC. AA. gestionan hospitales, centros de salud y AP.
- **Área de Salud (art. 56)**: estructura fundamental del sistema, con gestión unitaria. Se delimita por factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, viales y climatológicos.
  - Población: **entre 200.000 y 250.000 habitantes**. Excepciones: **Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla**. Cada provincia tendrá **al menos un Área**.
  - **Art. 65**: cada Área dispondrá de al menos **un hospital general**.
  - **Órganos del Área (art. 57)**: de **participación** (Consejo de Salud de Área), de **dirección** (Consejo de Dirección) y de **gestión** (Gerente).
  - En AP, el marco es la **ZBS (5.000-25.000 hab.)**; en AE, hospitales y centros de especialidades.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! El Consejo Interterritorial (CISNS) lo preside el **Ministro/a de Sanidad**, no el Presidente del Gobierno.
>
> ! Aprobación 25 de abril, BOE 29 de abril, vigor **19 de mayo** de 1986.
>
> ! El rango legal del Área es 200.000-250.000 hab. aunque la población real de un área murciana lo supere.

B2. Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia

- Organiza el sistema sanitario regional (ocho años después de la Ley General de Sanidad).
- **Plan de Salud** (Título II): documento estratégico que fija los objetivos y prioridades.
- **Mapa Sanitario** (Título III): divide el territorio en demarcaciones llamadas **Áreas de Salud**, y estas en **Zonas Básicas de Salud (ZBS)**.
- **Art. 26**: la organización y funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria (EAP) en las ZBS la regula el **Consejo de Gobierno mediante Decreto**.
- **Derechos (Título I, arts. 6-17)**: información clínica completa y veraz, confidencialidad e intimidad, **libre elección de médico, de enfermera y de centro**, y **segunda opinión**.
- **Defensor del Usuario**: tramita quejas y reclamaciones. Se adscribe a la **Consejería de Salud**, no al SMS, para ser independiente.
- **Art. 20**: crea el **Servicio Murciano de Salud (SMS)** como **ente público** con **personalidad jurídica propia**. Funciones **ejecutivas**: gestión de servicios, personal y centros. La planificación y la alta política quedan en la **Consejería**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El Defensor del Usuario **no** depende del SMS, sino de la **Consejería de Salud**.

! La ley murciana recoge la libre elección **también de enfermera** y la segunda opinión.

! **Consejería = estratega** (planifica y dirige el Plan de Salud). **SMS = ejecutor** (gestiona hospitales y personal).

B3. Mapa sanitario de la Región de Murcia

- Regulado por la **Orden de 14 de mayo de 2015**.
- Recursos: **9 Áreas**, **90 ZBS**, **85 Centros de Salud**, **176 consultorios**, **10 hospitales públicos** (9 de área + Psiquiátrico **Román Alberca**), 29 SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria, extrahospitalarios), 12 PAC (Puntos de Atención Continuada), 9 PEA (Puntos de Especial Aislamiento) y 16 centros de salud mental.
- Las **17 bases del 061 (Unidades Medicalizadas de Emergencias, UME)** dependen de la **Consejería de Salud**, no del SMS.

Área	Hospital de referencia	ZBS	Datos clave
I Murcia Oeste	Virgen de la Arrixaca	15	Hospital de área y de referencia regional (trasplantes)
II Cartagena	Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena (Santa Lucía + Santa María del Rosell)	17	**Mayor población** y más consultorios (44)
III Lorca	Rafael Méndez	11	**Más extensa** y dispersa; 3 PEA
IV Noroeste	Comarcal del Noroeste (Caravaca)	6	Montañosa y envejecida; 3 PEA
V Altiplano	Virgen del Castillo (Yecla)	3	Solo Yecla y Jumilla; la más concentrada; 0 PAC y 0 PEA
VI Vega Media	Morales Meseguer	17	Molina, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Archena
VII Murcia Este	Reina Sofía	12	Beniel, Santomera
VIII Mar Menor	Los Arcos del Mar Menor (San Javier)	5	Población que se multiplica en verano; 0 PAC y 0 PEA
IX Vega Alta	Lorenzo Guirao (Cieza)	4	**Menor población**

TRAMPAS DE EXAMEN

! Hay **90 ZBS pero 85 Centros de Salud**: no coinciden, porque algunas zonas comparten infraestructura.

! Una UME con base en la Arrixaca **no** pertenece al SMS.

! Fecha del mapa: **2015** (los distractores ponen 2013, 2017 o 2019).

B4. Estructura del Servicio Murciano de Salud

- Normas: **Decreto 148/2002** (estructura y funciones) y **Decreto 343/2023** (nueva estructura). Órganos de dirección, de gestión y de participación, en nivel central y periférico.
- **Consejo de Administración**: máximo órgano rector. Lo **preside el Consejero de Salud**. Aprueba presupuestos, plantilla y criterios de actuación. Se reúne de forma ordinaria **al menos cada 2 meses**; acuerdos por mayoría simple.
- **Director Gerente**: máxima autoridad ejecutiva unipersonal. De él dependen **4 Direcciones Generales (DG)**:
  - DG de Atención Primaria.
  - DG de Atención Hospitalaria.
  - DG de Salud Mental.
  - DG de Recursos Humanos.
- Dependen directamente del Gerente (transversales): **Subdirección General de Cuidados y Cronicidad**, de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación, de Actividad Concertada, de Tecnologías de la Información, Asuntos Jurídicos y Económicos, y la Secretaría General Técnica.

Órganos de participación (Decreto 54/2016, de 8 de junio, de órganos de participación del sistema sanitario)

Órgano	Claves
Consejo de Salud de la Región	Consultivo superior; adscrito a la **Consejería**; Pleno y Comisiones
Consejo de Salud de Área (obligatorio en las 9)	Preside el **Gerente de Área**. Vocales: **3 SMS**, **4 ayuntamientos**, **2 sindicatos** y **2 empresarios**. Secretario con **voz pero sin voto**
Consejo de Salud de Zona	**Facultativo** ("en su caso"); vecinos con coordinadores médico y de enfermería del EAP

Gestión periférica (en cada Área): Gerencia de Área Única

- Integra la Atención Primaria y la Especializada de cada área bajo un mando único. Órganos: Consejo de Dirección de Área, **Delegado de Salud y Consumo** (autoridad sanitaria, inspección, vigilancia) y **Gerente de Área**.
- Equipo directivo: Dirección Médica, **Dirección de Enfermería de Área** (enfermera con formación en gestión) y Dirección de Gestión y Servicios Generales.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La antigua **"Dirección General de Asistencia Sanitaria" ya no existe** tras el Decreto 343/2023.
! La Subdirección de **Cuidados y Cronicidad** depende del **Director Gerente**, no de la DG de AP.
! Consejo de Administración del SMS → **Consejero de Salud**. Consejo de Salud de Área → **Gerente de Área**.
! En el Consejo de Área, la mayoría es de los **ayuntamientos (4)**. Los Consejos de Zona son **opcionales**.
! El coordinador de enfermería de un centro de salud y el supervisor de una planta dependen de la **Dirección de Enfermería del Área**.

Otras preguntas del test de este tema

Estas preguntas del EIR caen en el test de este tema aunque su materia es de otros apartados del programa. Aquí tienes lo necesario para responderlas.

- **Conjunto Mínimo de Datos de los Informes Clínicos (CMDIC, RD 1093/2010)**: 8 documentos: informe de **alta**, de **consultas externas**, de **urgencias**, de **atención primaria**, de resultados de **laboratorio**, de pruebas de **imagen**, de **cuidados de enfermería** e **historia clínica resumida** (más en el tema 9).
- **Frecuentación**: número total de visitas de un año dividido entre las personas atendidas. Cuenta **todas** las visitas, no solo las de demanda. Depende sobre todo de la **morbilidad** del paciente, y también del estilo de cada profesional.
- **Mintzberg**: las organizaciones coordinan su trabajo con 5 mecanismos: **adaptación mutua**, **supervisión directa** y normalización de los procesos, de los resultados y de las habilidades.
- **Criterio, indicador y estándar** (calidad): el criterio es la condición que debe cumplir la buena práctica; el indicador, la medida que la cuantifica; el **estándar**, el nivel de cumplimiento aceptable (p. ej., «el 85-90 % de los usuarios atendidos antes de 10 minutos»).
- **PREMs y PROMs**: los **PREMs** miden la **experiencia** del paciente con el servicio (trato, esperas, información); los **PROMs**, los **resultados en su salud** que el propio paciente percibe tras el tratamiento.
- **Guía de Unidades de Cuidados Intensivos del Ministerio (2010)**: calcula las enfermeras necesarias con la escala **TISS** (cuánto trabajo de enfermería genera cada paciente); un paciente de **clase IV** necesita **1 enfermera para él solo (1:1)**.
- **Desastres (competencias del CIE)**: para proteger la resiliencia del personal, la medida más eficaz es formar en gestión emocional y autocuidado, fomentar la comunicación abierta y hacer sesiones de **debriefing** (puesta en común tras el suceso) y apoyo entre compañeros.
- **Cuidados de larga duración en personas dependientes** (Plan de Recuperación, componente 22): el modelo recomendado es la **Atención Centrada en la Persona**.